UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Rhumatologie
Ostéoporose
Avec patient
Sans geste clinique

Nom du rédacteur : CHAMPION Léa **Date de rédaction : 7 décembre 2023**

Relecture intra-ou transdisciplinaire :

Situation de départ N° 306 – Dépistage et prévention ostéoporose

Domaine de compétence n°1 (en sélectionner 1 SEUL) : Entretien/interrogatoire

Domaine de compétence n°1 (en sélectionner 1 SEUL) : Education/prévention

Attendus d'apprentissage de la situation abordée (cf. LISA : Catégorie:Situation de départ NG — LiSA (uness.fr)**):**

1-Chercher à l'interrogatoire et à l'examen clinique les facteurs de risque et causes secondaires d'ostéopathie fragilisante
2-Eduquer le patient et corriger les facteurs de risque modifiables

Objectifs de la station (items de connaissances abordés) :

1. Item 128 : Ostéopathies fragilisantes

Patient simulé nécessaire à la station : OUI Une femme entre 50 et 60 ans

Matériel nécessaire à la station

- Mannequin NON
- Brancard NON
- 1 table, 2 chaises

Exemple d'instructions au patient simulé

Rappel : seules les réponses précisées ci-dessous et les instructions peuvent être verbalisées. Le patient simulé ne doit rien dire d'autres que ce qui est précisé.

Synospis : (décrivez en quelques lignes ici le résumé du rôle et précisez s'il y a un contact physique ou non)

Ex : Vous avez 55 ans et vous venez suite à une fracture du col du fémur récente. Vous vous rendez à une consultation de rhumatologie pour rechercher des facteurs de risques d'ostéoporose .
Un étudiant en médecine va vous interroger

Identité/Contexte (éléments indispensables)	Nom : Madame Scott Age : 55 ans Vous êtes mariée, vous avez une fille et vous êtes ingénieur. Vous vivez dans une maison
Antécédents	Cancer du sein en rémission
Médicaments actuels/ Toxiques	*Aucun* *Tabac oui / pas de OH*
Etats d'esprit/ comportement	Posture assise Douleur : aucune Angoisse : faible Colère : aucune Autre :
Déroulement du scénario	Vous êtes assise autour d'une table. Lorsque l'étudiant vous demande pourquoi vous venez, commencez par : *Ex : Je viens parce qu'on m'a donné un rendez-vous avec vous suite à ma fracture du col que j'ai eu il y a 1 mois* Puis répondez aux questions de l'étudiant (cf tableau ci-dessous) et ne dévoilez les informations que s'il vous les demande spécifiquement.
Autres questions à poser au médecin, à quel moment	XX

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Vous ne répondrez aux questions suivantes que si l'évalué (étudiant-médecin) vous les pose. Si les questions de l'étudiant-médecin ne sont pas listées ci-dessous, répondre « je ne sais pas ».

Questions éventuellement posées par l'étudiant - médecin	**Réponses à donner par le patient simulé**
Utiliser un vocabulaire simple sans jargon médical *Si les questions sont compliquées le patient doit dire : « Comment ? Je ne comprends pas la question. »*	
Avez-vous des antécédents personnelles ?	Oui, un cancer du sein en rémission
Avez- vous des antécédents familiaux ?	Non
Est-ce que dans votre famille il y a eu des antécédents de fracture ?	Oui, ma mère a eu une fracture du poignet et de humérus à 55ans
Avez-vous des antécédents de fracture ?	Non
Est-ce que vous fumez ?	Oui 10 cigarette par jour
Depuis combien de temps vous fumez ?	30 ans
Est-ce que vous buvez ?	Non
Est-ce que vous avez des médicaments actuellement ?	Non
Avez-vous déjà prit des médicaments sur une longue durée ?	Oui, des anti aromatase pour mon cancer du sein
Avez-vous déjà prit des corticoïdes sur une période prolongé ?	non
Quand avez-vous eu la ménopause ?	Il y a 2 ans
Etes vous resté longtemps immobilisé ?	Juste le temps qu'on m'opère pour la fracture de mon col du fémur
Vous pesez combien ?	50 kg
Vous mesurez combien ?	1m 73
Avez-vous eu vos règles ?	Oui
Avez-vous eu des règles régulières ?	Non, des fois pendant 6 mois je ne les avez pas puis ca revenez.
Consommez-vous du calcium ?	Non, je n'aime pas les yaourt
Avez-vous une hyperthyroidie ?	non
Avez- vous une hyperparathyroidie ?	non
Avez- vous une hemochromatose ?	non
Avez-vous un hypogonadisme ?	non
Faites vous du sport ?	Oui, je cours 2 fois par semaine

Instructions à l'étudiant

Vous êtes interne en rhumatologie dans un bureau de consultation. Vous recevez Mme Scott âgée de 55ans qui vient suite a une fracture du col du fémur il y a 1 mois.

Vous avez **8 minutes** pour :

1. Réaliser un interrogatoire ciblé de la patiente
2. Expliquer ses facteurs de risques d'osteoporose et quelles mesures hygiéno-diététique à prendre

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction pour l'évaluateur (sans le barème)

	Cocher si fait
Tache 1	
Recherche les antécédents personnels de fracture	
Recherche antécédents familiaux de fracture	
Recherche la prise de médicaments de corticothérapie plus de 3 mois consécutifs	
Recherche un traitement pour le cancer du sein	
Recherche le poids	
Recherche quand à débuter sa ménopause	
Evalue l'apport calcique	
Recherche une immobilisation prolongée	
Recherche un tabagisme	
Recherche une cause secondaire : hypogonadisme, hyperparathyroidie, hemochromatose, hyperthyroidie (au moins 1 parmi les 4)	
Tache 2	
Conseil l'arrêt du tabagisme	
Conseil un apport calcique et vitamine D supplémentaire	
Incite le patient à maintenir une activité physique régulière	
Evoque la possibilité d'un traitement anti ostéoporotiques	
COMPETENCES GENERIQUES	
APTITUDE A QUESTIONNER	1 à 5
COMMUNICATION NON VERBALE	

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction avec le barème : non communiqué à l'évaluateur

	Pondération (entre 1 et 5)
Tache 1	
Recherche les antécédents personnels de fracture	2
Recherche antécédents familiaux de fracture	2
Recherche la prise de médicaments de corticothérapie plus de 3 mois consécutifs	2
Recherche un traitement pour le cancer du sein	1
Recherche le poids	1
Recherche quand à débuter sa ménopause	2
Recherche une aménorrhée	2
Recherche une immobilisation prolongée	1
Recherche un tabagisme	1
Recherche une cause secondaire : hypogonadisme, hyperparathyroidie, hemochromatose, hyperthyroidie (au moins 1 parmi les 4)	1
Tache 2	
Conseil l'arrêt du tabagisme	1
Conseil un apport calcique et vitamine D supplémentaire	2
Incite le patient à maintenir une activité physique régulière	1
Evoque la possibilité d'un traitement anti ostéoporotiques	1
	/20
COMPETENCES GENERIQUES	
APTITUDE A QUESTIONNER	1 à 5
	1 à 5
COMMUNICATION NON VERBALE	
Note totale	/30

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Annexe 1 fiche lisa

uness livret LiSA

Connaître les indications de l'ostéodensitométrie et des autres examens d'imagerie OIC-128-05-A

Fiche LiSA

en relecture

Objectif de connaissance	
Identifiant	OIC-128-05-A
Item parent	Ostéopathies fragilisantes
Rang	A
Intitulé	Connaître les indications de l'ostéodensitométrie et des autres examens d'imagerie
Description	None
Rubrique	Diagnostic positif
Contributeurs	
Ordre	5

La réalisation d'une **ostéodensitométrie** est nécessaire pour le **dépistage de l'ostéoporose**, c'est à dire :

· lors de la survenue d'une fracture d'allure ostéoporotique (ou sa découverte sur des radiographies),

· devant la découverte par l'interrogatoire d'un ou plusieurs facteurs de risque d'ostéoporose,

Parmi les indications d'ostéodensitométrie reconnues et remboursées par l'assurance maladie :

· quel que soit l'âge et le sexe :

o en cas d'antécédent de fracture sans traumatisme majeur

o en cas de pathologie ou de traitement potentiellement inducteurs d'ostéoporose (par exemple, l'hyperparathyroïdie primaire, l'hyperthyroïdie évolutive non traitée ou une corticothérapie de plus de trois mois)

· en sus d'une fracture non traumatique, chez la femme ménopausée :

o antécédent de fracture de hanche non traumatique chez un parent au 1er degré,

o un IMC < 19 kg/m^2,

o une ménopause précoce (avant quarante ans)

o un antécédent de prise de corticoïdes ≥ 3 mois consécutifs à une dose ≥ 7,5 mg/kg

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

uness livret
LiSA

Connaître les causes d'ostéoporose primitive et secondaire OIC-128-04-A

Fiche LiSA

Validée

Objectif de connaissance	
Identifiant	OIC-128-04-A
Item parent	Ostéopathies fragilisantes
Rang	A
Intitulé	Connaître les causes d'ostéoporose primitive et secondaire
Description	None
Rubrique	Étiologies
Contributeurs	
Ordre	4

L'ostéoporose primitive est plus fréquente chez la femme. Il s'agit de l'**ostéoporose post-ménopausique**. Les ostéoporoses secondaires sont plus fréquentes chez l'homme (environ 50 % des cas). La distinction ostéoporoses primitives et secondaires est parfois difficile à individualiser et les causes peuvent être intriquées.

La recherche d'une cause d'ostéoporose secondaire est importante, tout particulièrement chez l'homme mais pas que :

- hyperparathyroïdie primaire

- corticothérapie,

- hypogonadisme,

- hémochromatose génétique,

- maladies de l'appareil digestif : gastrectomie, résections intestinales étendues, entérocolopathies inflammatoires, syndromes de malabsorption (maladie cœliaque notamment),

- maladies inflammatoires chroniques en dehors de toute corticothérapie (polyarthrite rhumatoïde, spondyloarthrites...),

- hyperthyroïdie,

- anorexie mentale...

Catégories : Objectif de connaissance | OIC-128

uness livret
LiSA

Dépistage et prévention ostéoporose SDD-300

Situation de départ	
Intitulé	Dépistage et prévention ostéoporose
Famille	Prévention

Items de connaissance en rapport	Ostéopathies fragilisantes	
Items de connaissance reliés, non traités ici	Rachialgie	Dénutrition chez l'adulte et l'enfant
	Fractures fréquentes de l'adulte et du sujet âgé	Vieillissement normal : aspects biologiques, fonctionnels et relationnels. Données épidémiologiques et sociologiques. Prévention du vieillissement pathologique
	Hypercalcémie	Fractures chez l'enfant : particularités épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques
	Ménopause, insuffisance ovarienne prématurée, andropause, déficit androgénique lié à l'âge. (Voir item 330)	Dénutrition chez l'adulte et l'enfant
	Hyperthyroïdie	Diarrhée chronique chez l'adulte et l'enfant
	Adénome hypophysaire	Principe du bon usage du médicament et des thérapeutiques non médicamenteuses
Items de connaissance reliés en general	Ménopause, insuffisance ovarienne prématurée, andropause, déficit androgénique lié à l'âge. (Voir item 330)	

Attendu d'apprentissage dans la famille "Prévention"	Domaines	Compétence générique

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

uness livret
LiSA

Attendu d'apprentissage spécifique "de la situation abordée"	Domaines	Compétence générique
Prescrire selon les recommandations une ostéodensitométrie de dépistage	Education/prévention	Acteur de Santé Publique
Chercher à l'interrogatoire et à l'examen clinique les facteurs de risque et causes secondaires d'ostéopathie fragilisante	Entretien/interrogatoire	Clinicien
Suspecter à l'examen clinique un événement fracturaire	Examen Clinique	Clinicien
Evoquer une ostéoporose devant une fracture en fonction de son site et du mécanisme de survenue	Stratégie diagnostique	Réfléxif
Prescrire et interpréter le bilan biologique de première intention d'une ostéopathie fragilisante	Stratégie diagnostique	Clinicien
Evaluer le risque individuel de fracture par fragilité osseuse	Stratégie pertinente de prise en charge	Clinicien
Eduquer le patient et corriger les facteurs de risque modifiables	Education/prévention	Communicateur
Identifier les situations justifiant l'introduction d'un traitement pharmacologique anti-ostéoporotique	Stratégie pertinente de prise en charge	Clinicien
Expliquer les bénéfices et les risques du traitement pharmacologique et non pharmacologique	Annonce	Communicateur

Attendu d'apprentissage spécifique "Valorisation du stage"	Domaines	Compétence générique
Interpréter les résultats d'une ostéodensitométrie	Synthèse des résultats d'examens paracliniques	Clinicien

Annexe 2 collège de gériatrie

B. Éliminer une étiologie d'ostéopathie fragilisante autre que l'ostéoporose primitive

Ⓐ Parmi la liste des étiologies, les quatre premières sont à rechercher en priorité chez le patient âgé.

- **Carence en vitamine D**.
- **Hyperparathyroïdie** : le plus souvent secondaire (parathormone élevée et calcémie normale ou basse) à des apports calciques ou en vitamine D insuffisants (carence alimentaire, exposition solaire insuffisante, insuffisance rénale), plus rarement primitive (calcémie élevée et parathormone normale ou haute).

pour plus des livres médicaux gratuits,polycopiés, astuces, préparation:PACES,résidanat,ECNi,...visitez: www.sba-medecine.com

- **Myélome ou métastases osseuses**.
- **Immobilisation, sédentarité**.
- Insuffisance rénale chronique : au-delà de la carence en vitamine D, donne des anomalies du tissu osseux.
- Pathologies endocriniennes : hyperthyroïdie, hypercorticisme, hypogonadisme, acromégalie, insuffisance antéhypophysaire.
- Alcoolisme chronique, hémochromatose.
- Maladies de l'appareil digestif et malabsorption : gastrectomie, résections intestinales étendues, entérocolopathies inflammatoires, syndromes de malabsorption, maladie cœliaque, intolérance au lactose.
- Rhumatismes inflammatoires chroniques : polyarthrite rhumatoïde, spondylarthropathies.
- Maladies rares : ostéogenèse imparfaite, mastocytose, Ehler-Danlos, Marfan, hypercalciurie, carence en vitamine C.
- Iatrogène : diurétiques hypercalciuriants, inhibiteurs de la pompe à protons.

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

D. Facteurs de risque de fracture ostéoporotique

L'enjeu actuel du traitement de l'ostéoporose est d'identifier chez les patients ostéoporotiques les individus à risque de fracture devant bénéficier d'un traitement anti-ostéoporotique. Les quatre principaux facteurs de risque de fracture ostéoporotique sont :

- **l'âge > 60 ans** ;
- **un antécédent personnel de fracture ostéoporotique**, ce d'autant qu'il s'agit d'une fracture sévère, qui augmente significativement le risque de survenue d'une nouvelle fracture, indépendamment de la valeur de la DMO ;
- **la survenue d'une chute** [27] et **le risque de chute**, particulièrement chez les personnes âgées. La démarche devant une chute doit donc être entreprise de manière très rigoureuse (cf. chapitre 12), afin de mettre en place une intervention qui limitera le risque de récidive ;
- **la diminution de la densité minérale osseuse** (DMO) est le déterminant principal du risque de fracture ostéoporotique. Les études épidémiologiques montrent qu'une diminution d'un écart-type de la DMO par rapport à la moyenne pour l'âge multiplie par deux le risque de fracture. Cependant, la valeur de la DMO ne permet d'expliquer qu'une partie de ce risque et il existe un important chevauchement des valeurs de DMO entre les sujets avec et sans fracture.

B **Il existe d'autres facteurs de risque de fracture** (HAS) :

- antécédent de corticothérapie systémique ;
- antécédent de FESF chez un parent du premier degré ;
- masse corporelle < 19 kg/m² ;
- ménopause précoce (< 40 ans) ;
- tabagisme ;
- alcoolisme ;
- baisse de l'acuité visuelle ;
- troubles neuromusculaires et orthopédiques.

C. Stratégie thérapeutique de l'o[illegible]se

124%

1. B En premier lieu, toujours penser à :
   - calcium et vitamine D ;
   - mesures générales.
2. Choisir un traitement de l'ostéoporose.
3. Prescrire un cycle de 3 à 5 ans selon la molécule (fig. 6.7).
4. Anticiper les séquences thérapeutiques (après dénosumab ou tériparatide).
5. Assurer le suivi.
6. Anticiper la réévaluation.

1. Mesures générales devant être associées aux traitements médicamenteux

- Suppression des facteurs de risque [illegible]

TUT'ECOS